

Биполярная трансуретральная резекция доброкачественной гиперплазии предстательной железы

Турысбеков К.Т.

Центральная клиническая больница УДПРК

Актуальность

В последние годы в связи со значительным ростом населения планеты в возрасте старше 60 лет увеличивается заболеваемость доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). Наиболее эффективным в терапии ДГПЖ остается хирургическое лечение ДГПЖ. На сегодняшний день золотым стандартом в ее оперативном лечении является трансуретральная резекция, с помощью которой удастся оперировать значительную часть больных. В тоже время по литературным данным при данном методе лечения у 20 % больных развиваются различные осложнения. В этой связи ведется поиск новых методов лечения больных ДГПЖ. Одним из таких методов является биполярная трансуретральная резекция простаты.

Цель исследования

– изучить особенности применения метода биполярной трансуретральной резекции ДГПЖ.

Материал и методы исследования

Материалом для ретроспективного анализа послужили 48 случаев биполярной ТУР ДГПЖ, проведенных в урологическом отделении ЦКБ УДПРК. Возраст больных варьировал от 62 до 81 года. Объем резецированной предстательной железы составлял от 38 до 160 куб. см.

Биполярная ТУР ДГПЖ проводилась на оборудовании KARL STORZ (ГЕРМАНИЯ).

Больные предъявляли жалобы на расстройство мочеиспускания, проявляющееся затруднением при мочеиспускании, увеличением ночных мочеиспусканий, чувством неполного опорожнения мочевого пузыря и вялой струей мочи. Всем больным проведено измерение суммарного балла по междуна-родной системе суммарной оценки симптомов при заболеваниях предста-тельной железы, по 35 бальной шкале; пальцевое ректальное исследование; общеклинические исследования, рентгенография почек и мочевого пузыря; абдоминальное и трансректальное УЗИ предстательной железы; урофло-уметрия с определением наличия и количества остаточной мочи; определе-ние уровня простатоспецифического антигена по показаниям.

Результаты

Послеоперационное пребывание в стационаре 6,5 к/дн, срок дренирования мочевого пузыря - 24 часа. Назначались уроантисептики, антибактериальные препараты и гемостатики. Интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений не наблюдалось.

Выводы

Преимуществами биполярной ТУР ДГПЖ являются более короткий период дренирования мочевого пузыря после операции; невозможность возникновения ТУР - синдрома; короткий период пребывания в стационаре после операции.